

Fecha Última Actualización: 25-03-2025 17:49:05

Página 1 de 2

Información Paciente

Nombre : Juan Galvarino García González **Rut** : 6.134.128-5 **N° Archivo** : 1003871
Edad : 77a 3m 15d **Fecha Nacto**: 10/12/1947 **Sexo** : Masculino
Dirección : Calle Ejercito Libertador 4184 Casa156 Co **Comuna** : Puente Alto **Teléfono** : 926363542

N° Epicrisis
435133

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji **Fecha Ingreso** : 24/03/2025 10:19 **Días Estadía** : 1
Unidad de Egreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji **Fecha Egreso** : 25/03/2025 17:03

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

CIRUGIA PROGRAMADA

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

CIRUGIA TORAX

ANTECEDENTES

- Mórbidos: HTA, dislipidemia, gonartrosis, FA sin TACO
- Quirúrgicos: resección + biopsia tumor palpebral OI, hernioplastia inguinal bilateral (2022)
- Medicamentos: pregabalina 75 mg AM y 150 mg PM, bromuro de ipratropio/fenoterol, paracetamol SOS
- Alergias: No conocidas
- Hábitos: Tabaco (-), OH ocasional, Drogas (-)
- Hospitalizaciones recientes: 28/05 a 27/08/24 por neumonía por influenza A sobreinfectada por S. Pyogenes. Cursa con insuficiencia respiratoria aguda grave, requiere VMI e ingreso a UCI donde presenta múltiples interurrencias entre las que destaca bacteriemia por PSAE MS + E. faecium vanB, bacteriemia por E. Coli BLEE, AKI KDIGO III con necesidad de TRR resuelta, Fístula broncopleurale en tratamiento (mantiene drenaje pleural pigtail al alta), TQT percutánea hasta 23/08, UPP G3 sacra y talar bilateral
- Social: actualmente dependiente para ABVD

Paciente con antecedente de neumonía necrotizante, empiema. Evoluciona con fistula broncopleurale de LSD persistente.

Ingresar para manejo endoscópico el 24/03/25.

Anestesia general y tubo simple. FBC sin secreciones. Se evidencia en segmento anterior de LSD bronquio con aparente trayecto fistuloso. Se intenta comprobar sitio de fuga aérea con fogarty, frustrado. Se inyecta histoacryl 0,5m + lipiodol 0,5ml a través de inyector en bronquio segmentario antes descrito. Se comprueba cese de fuga aérea en drenaje. Hay histoacryl que ocluye parcialmente resto segmentos de LSD, no se logra resecar. Procedimiento bien tolerado.

Evoluciona favorablemente, hemodinámicamente estable, normocardico, sin dolor. Afebril. Sin disnea, saturando adecuadamente a FiO2 ambiental, UMA (-). Buena tolerancia oral a régimen. Deambulando sin conflicto. Moviliza gases por boca y ano. Diuresis (+).

Fecha Epicrisis : 25/03/2025 17:49

Página 1 de 2

En condiciones de alta.

Diagnóstico de Egreso

ENFERMEDADES DE LA TRÁQUEA Y DE LOS BRONQUIOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE -

Condición de Egreso Alta Domicilio

Egreso con Catéter Doble J:NO

Evoluciona favorablemente, hemodinámicamente estable, normocardico, sin dolor. Afebril. Sin disnea, saturando adecuadamente a FiO2 ambiental, UMA (-). Buena tolerancia oral a régimen. Deambulando sin conflicto. Moviliza gases por boca y ano. Diuresis (+).
En condiciones de alta.

Plan Post Alta

- Reposo relativo (no realizar esfuerzo físico ni actividad física por 1 mes)
 - Mantener actividad en domicilio, levantarse y caminar. Evitar reposo en cama.
 - Régimen común
 - Evitar consumo y/ exposición de tabaco u otro irritante respiratorio.
 - Paracetamol 500 mg, 2 comprimidos cada 8 horas por 7 días (vía oral)
 - Ketoprofeno 50 mg 1 comprimido cada 8 horas por 3 días máximo. (Vía oral) (Solo en caso de dolor)
 - Pregabalina 75 mg, 1 comprimido cada 24 horas por 30 días (vía oral)
 - Omeprazol 20 mg, 1 cápsula cada 24 horas por 7 días. (vía oral)
 - Bromuro ipatropio , 2 puff cada 8 horas con AEC (INH)
 - Reiniciar medicamentos crónicos.
- Radiografía Tórax ambulatoria control, acudir con resultado a control en policlínico.
- Control en 2 semanas en policlínico Cirugía Tórax, pedir hora en CDT pasillo 11 en 1° piso.
- Consultar en servicio de urgencia en caso de: dificultad respiratoria, fiebre, vómitos a repetición, sangrado, eritema y/o calor de heridas y salida de pus por herida o en caso necesario.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente

Cristobal Flores Rebuffo
Médico Tratante (Staff)